جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : امنه احمد حسن قناوي
المحافظة : القليوبيه **الحي / المدينة :** شبرا الخيمه **العنوان :** =
رقم البطاقة : 27906061401025 **رقم التليفون :** 01145404642 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 17-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 06-06-1979 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : أبحاث أورام تصوير مقطعي للصدر والبطن والحوض بالصبغة [11129] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: امنه احمد حسن قناوى
National ID: 27906061401025

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL EGYPTE

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Contrast-enhanced CT of chest, abdomen and pelvis.

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



امنه
احمد حسن قناوى
١١ش شاهين-عزبة السماع
شبرا الخيمه ثان - القليوبية

٢٥ ١٠ ١٤ ٠٦ ٠٦ ٢٧٩

JD5117884

٢٧٩٠٦٠٦١٤٠١٠٢٥ ٢٠٢١/١١
حاصلة على معهد فنى صناعى

أنثى مسلمة متزوجة
اسامه كمال احمد محمد
١١ البطاقة سارية حتى ٢٠٢٨/١١/١٦

National ID · Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

Patient Name	: الأستاذه / امنه احمد حسن قناوى	Request No.	: 13006789
Patient No.	: 27906061401025	Request Date	: 24/02/2022
Path No.	:	Verification Date	: 14/03/2022
Sex	: Female	Financial Category	: ادوار مصر السلام - فئة الدولة
Age	: 42 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc	:	Registered by	: manva mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data:
Left breast cancer.

Nature of the specimen:
Left simple mastectomy & sentinel lymph nodes.

Gross Examination:
Two specimens were received:
1- Left simple mastectomy specimen measured 20x18x4cm, covering skin piece measured 20x11cm, nipple was unremarkable grossly.
- Tumor extent: Two nodular rubbery to soft greyish tan and brownish masses.
o Size: 2.8x2.5cm and 1.5x1cm (separated from each other by 3cm)
- Localization: LOQ
- Distance from margins: 1cm from the deep margin and 1.5cm from the skin.
2- Sentinel lymph nodes specimen: A fibrofatty tissue piece measured 3x2x2cm, containig 4 lymph nodes, up to 2.3x1.5cm.

Microscopic examination:
- Histological type: Bifocal invsive duct carcinoma, with 10% DCIS.
- Grade 2(differentiation+ nuclear pleomorphism + mitosis): G (3+2+1)
- Angioinvasion: No
- No perineural invasion.
- Lymph node involvement: All sentinel lymph nodes were free (0/4)
- Resection Margins: Free deep margin.
- Free nipple and areola.
- Additional pathologic findings: No
- Frozen section: All sentinel lymph nodes were free (0/4)

Verified by :
abdelrahman ibrahim

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Name: امنه احمد حسن **MR. :** 6594	

Detailed Medical Report

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		**بشأن تقرير طبي للمريض**	
بقسم:		**رقم طبي:**	

ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول :		**تاريخ وساعة الخروج :**	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه

The patient has metastatic breast cancer (MBC) to the bones and is currently receiving letrozole (Femara) in combination with leuprolide acetate (Zoladex) and zoledronic acid (Zometa). A new assessment has been requested.

The patient's disease is triple-positive metastatic breast cancer to bone. The current regimen includes letrozole (Femara) and leuprolide acetate (Zoladex); anti-HER2 therapy has not been initiated. The clinical plan includes evaluation of progression with repeat bone scan, chest-abdomen-pelvis CT, and continuation of zoledronic acid after laboratory results are reviewed.

The patient continues on letrozole (Femara) with supportive care for the next three months. The next follow-up is scheduled for 15 October 2026, at which time a bone scan and CT will be performed due to the patient's lack of complaints.

تحريرا في ,

التاريخ :	19-09-2026	**الوقت :**	

الطبيب المعالج : نهي سعيد علي محمد

يعتمد ,

Patient Name	: الأستاذه / امله احمد حسن فتاوى	Request No.	: 13006789
Patient No.	: 27906061401025	Request Date	: 24/02/2022
Path No.	: 535/2022	Verification Date	: 10/04/2022
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - تغطية الدولة
Age	: 42 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc.	:	IHC No.	:
		Registered by	: .marwa mohamed yousse

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

Clinical Data:
Left breast cancer.

Nature of the specimen:
Left simple mastectomy & sentinel lymph nodes.

Gross Examination:
Two specimens were received:
1- Left simple mastectomy specimen measured 20x18x4cm, covering skin piece measured 20x11cm, nipple was unremarkable grossly.
• Tumor extent: Two nodular rubbery to soft greyish tan and brownish masses.
o Size: 2.8x2.5cm and 1.5x1cm (separated from each other by 3cm)
• Localization: LOQ
• Distance from margins: 1cm from the deep margin and 1.5cm from the skin.
2- Sentinel lymph nodes specimen: A fibrofatty tissue piece measured 3x2x2cm, containig 4 lymph nodes, up to 2.3x1.5cm.

Microscopic examination:
• Histological type: Bifocal invsive duct carcinoma, with 10% DCIS.
• Grade 2(differentiation+ nuclear pleomorphism + mitosis): G (3+2+1)
• Angioinvasion: No
• No perineural invasion.
• Lymph node involvement: All sentinel lymph nodes were free (0/4)
• Resection Margins: Free deep margin.
• Free nipple and areola.
• Additional pathologic findings: No
• Frozen section: All sentinel lymph nodes were free (0/4)

Verified by :
abdelrahman ibrahim

Immunohistochemistry
[[DOCTYPE:IHC]]

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصحة والسكان
المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى دار السلام
الأشعة

Patient Name: Amnah Ahmed Hassan Kenawy	Date : 30/11/2023
Exam : MAMMOGRAPHY BOTH	Age : 44 Year(s)
Medical ID: 188/2022	

RIGHT BREAST MAMMOGRAPHY WITH BILATERAL US

Indication:

Patient had left MRM

Technique

- right breast MLO and CC views
- Bilateral ultrasound

Report:

- The right breast is predominant fatty pattern (ACR a)
- No spiculated masses or grouped microcalcifications.
- Complementary ultrasound also showed no right breast solid or cystic masses
- Normal skin thickness and nipple-areola complex, with average caliber of the retro-areolar ducts
- Nonspecific right axillary LN, with preserved fatty hila and uniform cortical thickness.
- Free left operative bed with no evidence of recurrent mass lesions
- Free left infra and supra clavicular regions.

Opinion:

- Left MRM with free operative bed with no evidence of recurrent mass lesions
- No right breast suspicious findings (BIRADS 2)

Yours truly ,

Dr/Asmaa Zeinhom, Msc

Not Approved

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]

Women's Health Outreach Program

Name: Amna Ahmed hassan
Date: 7/02/2022

Contrast Enhanced Full field Digital Mammography

Clinical summary: Known case of left IDC

Technique

Pre & post contrast Mediolateral oblique and CC views
Targeted High resolution ultrasound

Detailed Findings

Left breast

- Heterogeneously dense (ACRC)
- Multiple UOQ & inner central mass lesions
- **Contrast enhanced images demonstrated:** Mild background enhancement
- Multiple masses seen as follow:
  1. Outer central middle one third partially ill defined oval shaped mass lesion shows heterogeneous mild mass enhancement, it measures2.1x2.6x2.3cm located at about 6cm from the nipple. Index lesion
  2. Adjacent partially ill defined oval mild enhancing lesion seen in the anterior one third located at about 3cm from the nipple and 1.4cm from index lesion, it measures 1.8x1.9x1.4cm
  3. UOQ posterior one third irregular shaped mass lesion with speculated margins shows moderate mass enhancement, it located 10cm from the nipple and 4cm posterior to the index lesion, it measures 1.7x1.8x.9cm.
  4. Inner central middle one third well circumscribed faint enhancing round lesion seen 7.5cm from the nipple 7 8cm from index lesion, it measures 0.8cm
  5. Faint enhancing retroareolar small nodule measures 3mm
- Complementary us shows indeterminate level I LNS shows diffuse cortical thickness up to 0.5cm measures 1.8cm

Right breast

- Heterogeneously dense (ACRC)
- No asymmetric densities , distortion or suspicious clusters of microcalcifications.
- **Contrast enhanced images showed:** Mild background enhancement
- no pathological contrast uptake.
- Normal skin/nipple/areolar complex.
- Preserved axillary LNs
- **Conclusion:**

-Left breast: multicenteric malignant process as described (BIRADS 6).
-Right breast: Normal study (BIRADS 1).

Best regards,

Dr. Marwa Ramzy

Dr Hanaa Abo El Magd

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]

جونستاف زوسي

مبادرة رئيس الجمهورية
لدعم صحة المرأة المصرية

الست المصرية هي صحة مصر

MDT FORM 22/9/2025 G

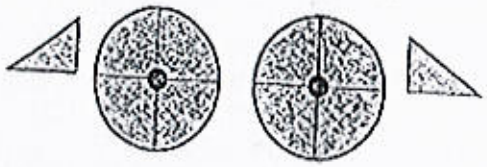
Name	امنه احمد حسن	MRN	C.cc ١٨٨
Age	٤٦	ID	
Menopausal status	Pre menopausal	Phone	٠١١٢٤٧٥٤١٩٥
NRS SCORE		Marital status	Married.
BMI		Family history	
CO morbidity		REASON OF MDT	

Clinical Data

BX: IDC

ER:	PR:	HER 2:	Ki67:
8/8	5/8	+Ve	

R L



Sonomammography:

Mets Workup:

TNM

Recommendations: H simple Mastectomy sLNB 2/2022 → T2 bilateral N0M0 4 TC then sc Herceptin x17 + tamoxifen on 12/2024 → femur pathological fracture by intermedullary n/l + PT on tamoxifen + Zoledex, Pending MRI femur.

MDT OUTCOME & PLAN

for: ① PET CT or CT CAP + bone scan
② Results of pathology.
③ Follow up in clinic with Zoledex / Femara / Tamoxifen (if pre-menopausal)

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric
CCS/9/CC		Normal Rumbi			

MDT Form
[[DOCTYPE:MDT_FORM]]